



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
NEONATUS INTENSIVE CARE UNIT
(NICU)**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelayanan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) Tahun
2025

Disusun oleh:
Kepala Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU)



(dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M. Biomed)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes.,AFP.,CCht.,CI.,CHEA.,CHQP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

(Ns. Heni Indra Wulandari, S. Kep., M.Kep)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2023 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah Pedoman Pelayanan Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Ditetapkan di Pasuruan Pada
tanggal 25 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulandari, S. Kep., M.Kep

TIM PENYUSUN

Pengarah & Editor: Dr. dr. Aslichah, M. Kes.,AFP.,CCht.,CI.,CHEA.,CHQP

Pelaksana

1. Heni Indra Wulansari, S. Kep, Ns, M. Kep
2. dr. Esty Purwaningrum, Sp.A
3. dr. Muhammad Irawan, Sp.A
4. dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M.Biomed
5. dr. Qashastia Sukma Paripurna, Sp.A
6. Sisca Puspitasari, S. Kep, Ns
7. Ayu Mayang Priningtyas, S.Kep.Ns
8. Dan seluruh staf di ruang Neonatologi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN..... 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Tujuan Pedoman..... 5

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan..... 5

1.4 Batasan Operasional..... 6

1.5 Dasar Hukum 6

BAB II STANDART KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia 8

2.3 Distribusi Ketenagaan 8

2.4 Pengaturan Jaga..... 8

BAB III STANDART FASILITAS

3.1 Denah Ruangan 10

3.2 Standart Fasilitas..... 10

3.3 Persyaratan Khusus 10

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

4.1 Kriteria Pasien Masuk NICU 12

4.2 Kriteria Pasien Keluar NICU 12

4.3 Monitoring dan Evaluasi Pasien..... 12

4.4 Jenis Pelayanan diruang NICU..... 13

4.5 Penggunaan Alat Medik..... 13

4.6 Hal-hal Yang Harus Diperhatikan..... 14

4.7 Pasien Pulang 14

4.9 Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Pelayanan 15

BAB V LOGISTIK

5.1 Barang Tetap 16

5.2 Barang Habis Pakai..... 17

BAB VI KESELAMATAN PASIEN

6.1 Pengertian..... 18

6.2 Tujuan..... 18

6.3 Tata Laksana Keselamatan Pasien	18
BAB VII KESELAMATAN KERJA	
7.1 Pengertian.....	20
7.2 Prinsip Dasar Usaha Keselamatan Kerja	20
7.3 Tujuan Keselamatan Kerja.....	20
7.4 Kapasitas Kerja dan Beban Kerja	21
7.5 Lingkungan Kerja dan Penyakit Kerja yang Ditimbulkannya	21
7.6 Klasifikasi Kecelakaan Kerja	21
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU	
8.1 Upaya Peningkatan Mutu Keperawatan	23
8.2 Monitoring dan Evaluasi Mutu Keperawatan	23
BAB IX PENUTUP	
LAMPIRAN	



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 935.109/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

TENTANG

**PEDOMAN PELAYANAN *NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT* (NICU)
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan yang efektif dan efisien bagi pasien Unit Intensive di rumah sakit
- b. Bahwa dengan ditetapkannya pedoman pelayanan Unit Intensive di rumah sakit dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010 perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi pelayanan Unit Intensive di rumah sakit
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Unit Intensive di rumah sakit
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 635.1/DPM/I-KEP/DIR/XII/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT (NICU)**

BAB I

Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

Pasal 1

- 1) *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)* adalah bagian dari bangunan rumah sakit dengan katagori pelayanan kritis, selain instalansi bedah, instalasi gawat darurat, dan High Care Unit
- 2) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang kriteria yang ditetapkan untuk masuk rawat di pelayanan NICU
- 3) NICU adalah ruangan intensive penerima rujukan pasien dari rumah sakit lain sesuai standart dan fasilitas yang dimiliki dan bila pasien memerlukan perawatan intensive yang lebih tinggi tingkatannya dapat di rujuk ke rumah sakit lain sesuai dengan kondisi pasien.

Pasal 2

- 1) Kriteria dokter NICU adalah telah mengikuti pelatihan / pendidikan perawatan anak dan telah mendapat sertifikat melalui program pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh perhimpunan profesi yang terkait.
- 2) Staf yang ada di NICU adalah staf yang berkompeten dan terlatih.

Pasal 3

- 3) Indikasi pemeriksaan laboratorium dan radiologi berdasarkan permintaan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) atau dokter konsulen lain berkoordinasi dengan dokter penanggung jawab NICU.
- 4) Setiap permintaan laboratorium dan radiologi diinput oleh staf untuk selanjutnya di informasikan pada bagian terkait.

BAB II

KRITERIA KELUAR MASUK NICU

Pasal 4

- 1) Staf yang kompeten dan berwenang dari NICU terlibat dalam menentukan kriteria.
- 2) Staf terlatih untuk melaksanakan kriteria
- 3) Pasien yang membutuhkan perawatan di NICU dan atau keluarganya harus mendapatkan penjelasan serta memberikan persetujuan untuk dirawat di NICU.
- 4) Catatan medis pasien yang diterima masuk di atau keluar dari unit intensif atau unit spesialisik memuat bukti bahwa pasien



memerlukan kriteria masuk atau keluar.

Pasal 5

- 1) Ada peraturan tentang kriteria masuk dan keluar NICU yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, meliputi:
 - a. Kriteria masuk NICU: Syndrome Gawat Nafas/ Respiratory Distress Syndrome, Retinopathy of Prematurity (ROF), *Transient Tachycardia of Newborn* (TTN), *Hyalin Membrane Disease* (HMD), pneumonia neonatal, asfiksia, aspirasi meconium, ancaman gagal nafas dan gagal nafas, *Bronkopleumony displasia* (BPD), memerlukan oksigenasi intensif dan agresif, anemia, apnea, Perdarahan Saluran Cerna atas dan bawah yang masif, *Necrotizing Enterocolitis Necrotion* (NEC), Syok Hipovolemik, Post Resusitasi, Kejang, Kern ikterik/ encephalopathy hiperbilirubinemia, *Hemorrhagic Disease of newborn* (HDN), Bayi berat badan lahir amat/ sangat rendah (<1500 gram) atau bayi dengan kelahiran usia gestasi <34 minggu dengan batas usia 60 hari setelah kelahiran., Icterik Neonatorum yang perlu terapi fototerapi dan terapi cairan dengan hasil bilirubin bayi >20 mg/dl, Neonatus yang memerlukan nutrisi parenteral total atau parsial.
 - b. Yang menentukan pasien bisa masuk NICU adalah dokter kepala NICU.
 - c. Apabila NICU dalam keadaan kosong, maka semua dokter diperkenankan untuk merawat pasien di ruang NICU sesuai dengan kriteria pasien masuk NICU diatas.
 - d. Kriteria keluar NICU: Bayi telah menunjukkan tanda vital stabil di boks terbuka selama 24-48 jam. Normalnya, suhu tubuh bayi 36,5⁰ C-37,5⁰ C, frekuensi pernapasan 30-40 x/mt, nadi 120-160 x/mnt, keberhasilan menyusui sudah mulai tercapai, penambahan berat badan dengan pemberian asupan per oral telah terlihat, semua obat yang diperlukan dapat diberikan per oral, nilai laboratorium telah normal, ibu dan ayah memperlihatkan kemampuan untuk mengasuh neonatus, pasien meninggal, rujuk, dan pulang Paksa (APS).



BAB III

KETENTUAN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

Pasal 6

- 1) Setiap penggunaan peralatan medis di ruang NICU diinformasikan kepada penanggung jawab pasien.
- 2) Ada pemeriksaan thorax terlebih dahulu sebelum masuk NICU dan dinyatakan bersih oleh dokter jaga IGD atau dokter ruangan dan atau DPJP.

Pasal 7

- 1) Pasien yang dirawat di ruang *Neonatal Intensif Care Unit* tidak diperbolehkan untuk di dampingi maupun dikunjungi selama dirawat di ruangan, apabila terjadi perubahan kondisi pasien staf wajib memberikan informasi kepada keluarga.

Pasal 8

- 1) Tindakan yang bersifat kedokteran harus dikerjakan oleh tenaga medis tetapi dengan pertimbangan yang memperhatikan keselamatan pasien tindakan tindakan tertentu dapat didelegasikan kepada tenaga kesehatan non medis yang terlatih.
- 2) Pencatatan nilai – nilai pengukuran tanda vital secara berkala di lakukan perawat NICU 1 jam sekali dengan interval di sesuaikan dengan kondisi pasien pada lembar kardek NICU
- 3) Pemantauan secara umum dan khusus. Setiap pagi hari oleh dokter jaga dan perawat NICU dan dikoordinasikan dengan dokter DPJP.
- 4) Pada keadaan darurat, untuk kepentingan terbaik pasien, dokter jaga NICU atau dokter spesialis anestesi dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan dan informasi dapat diberikan pada kesempatan pertama.
- 5) Pada pasien yang berada dalam tahap terminal dan tindakan resusitasi diketahui tidak akan menyembuhkan atau memperbaiki kualitas hidup pasien, dokter dapat membuat keputusan untuk tidak melakukan resusitasi.

Pasal 9

- 1) Penundaan dan keterlambatan pelayanan di rawat inap harus disampaikan kepada pasien.
- 2) Semua pasien diberitahu alasan penundaan dan keterlambatan pelayanan dan diberi informasi tentang alternative yang tersedia sesuai kebutuhan klinik pasien dan dicatat di Rekam Medis.

Pasal 10

- 3) Dilakukan rencana pemulangan pasien (*Discharge Planning*) bagi pasien yang rencana pemulangannya kompleks dimulai sejak awal pasien masuk rawat inap melibatkan semua PPA terkait serta difasilitasi oleh MPP, untuk kesinambungan asuhan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien.



- 4) *Discharge Planning* dilakukan secara terintegrasi antar PPA terkait dan difasilitasi manager pelayanan pasien (MPP).

Pasal 11

- 5) Semua pasien rawat inap ditentukan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang bertanggung jawab mengelola pasien sesuai dengan kewenangan klinisnya serta melakukan koordinasi dan kesinambungan asuhan.
 - a. DPJP yang ditunjuk harus tercatat namanya di rekam medis.
 - b. DPJP memberikan keseluruhan asuhan selama pasien di Rumah Sakit dan berkolaborasi serta komunikasi dengan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya.

BAB IV

RUJUKAN KELUAR

Pasal 12

- 1) Rumah Sakit memiliki staf terlatih yang mengelola rujukan.
- 2) Rumah Sakit bekerja sama dengan Rumah Sakit rujukan.
- 3) Rumah Sakit melakukan rujukan sesuai dengan kebutuhan pasien untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Rujukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep



**LAMPIRAN I :
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA
NOMOR : 935.109/RSPHS/I-
PER/DIR/XI/2025
TENTANG : PEDOMAN PELAYANAN NICU
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi di antara negara Asean. Menurut Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) 2002-2003, angka kematian sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup. Milenium Development Goals 2015 diharapkan turun menjadi < 20 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab terbesar kematian neonatus di Indonesia adalah BBLR (29%), Asfiksia (27%), Tetanus neonatorum (10%), masalah pemberian ASI (9,5%), masalah Haematologi (5,6%), dan infeksi (5,4%).

Dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya derajat sosial ekonomi masyarakat Indonesia juga menambah tuntutan mutu pelayanan pada bayi baru lahir yang semakin tinggi. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dan lebih khusus Neonatus Intensive Care Unit berusaha senantiasa meningkatkan pelayanan dengan melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku dalam pelayanan kepada pasien. Berbekal panduan dasar serta ditambah beberapa referensi maka disusunlah pedoman ini.

1.2 Tujuan Pedoman

1. Tujuan Umum

Sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, prosedur, dan segala proses di bidang pelayanan intensive di Rumah Sakit Prima Husada

2. Tujuan khusus

- a. Memiliki standar ketenagaan di NICU
- b. Memiliki standar fasilitas di NICU
- c. Memiliki tata laksana di NICU
- d. Memiliki standar logistik di NICU
- e. Memiliki standar keselamatan pasien di NICU
- f. Memiliki standar keselamatan kerja di NICU
- g. Memiliki standar pengendalian mutu di NICU

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan

- a. Ruang lingkup pelayanan NICU Rumah Sakit Prima Husada adalah asuhan neonatal dengan ketergantungan tinggi (Ruang Rawat Neonatus Asuhan Khusus) yaitu memerlukan perawatan intensif dengan kemampuan memberikan alat bantu nafas menggunakan CPAP (*Continuos Positive Airway Pressure*) dan Ventilator serta memerlukan



observasi secara ketat.

1.4 Batasan Operasional

- a. Gangguan respirasi
- b. Gangguan kardiovaskuler
- c. Skor APGAR kurang dari 4
- d. Berat lahir sangat rendah (> 1500 gram)
- e. Kurang bulan dengan umur kehamilan > 32 minggu
- f. Gangguan saluran cerna berat, seperti NEC dan perdarahan saluran cerna
- g. Bayi dari ibu Diabetes
- h. Bayi yang lahir dari kehamilan berisiko tinggi atau persalinan dengan komplikasi
- i. Gawat nafas yang tidak memerlukan ventilasi bantuan
- j. Hiperbilirubinemia yang perlu terapi sinar
- k. Sepsis neonatorum
- l. Hipotermi

1.5 Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 635.1/DPM/I-KEP/DIR/XII/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.



BAB II

STANDART KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi sumber daya manusia di Instalasi NICU adalah :

1. Tenaga Medis
 - a. Terdidik dan bersertifikasi sebagai seorang spesialis anak melalui program pelatihan dan pendidikan yang diakui oleh perhimpunan profesi yang terkait
 - b. Menunjang kualitas pelayanan NICU dan menggunakan sumber daya secara efisien
 - c. Mendarmabaktikan lebih dari 50% waktu profesinya dalam pelayanan NICU
 - d. Bersedia berpartisipasi dalam suatu unit yang memberikan pelayanan 24 jam/ hari, 7 hari/ minggu
 - e. Mampu melakukan prosedur critical care, antara lain:
 - 1) Memasang dan mempertahankan jalan napas termasuk intubasi dan ventilasi mekanis
 - 2) Mengambil kateter intravaskuler untuk monitoring invasive maupun terapi invasive Resusitasi jantung paru
 - f. Selalu mengikuti perkembangan mutakhir dengan membaca literature kedokteran
 - g. Berpartisipasi dalam program-program pendidikan dokter berkelanjutan
2. Tenaga Keperawatan

Perawat yang bertugas di *Neonatal Intensive Care Unit* Rumah Sakit Prima Husada harus terlatih serta jumlahnya sesuai dengan ketersediaan inkubator, cuve, CPAP, Ventilator, maupun box yang terpakai.

2.1 Distribusi Ketenagaan

Standar pelayanan *intensive care unit* pada rumah sakit tipe C terdiri dari :

NAMA JABATAN	WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
Kepala Instalasi NICU	1 shift	1 orang
Kepala ruang NICU	1 shift	1 orang
Penanggung Jawab shift	3 shift	4 orang
Perawat Pelaksana	3 shift	4 orang

2.2 Pengaturan Jaga

Pengaturan Jaga di NICU adalah sebagai berikut :

1. Tenaga medis :
 - a. Dokter Spesialis Anak berjaga secara on call
 - b. Dokter Umum berjaga secara on site, dalam 24 jam terbagi menjadi 3 waktu dinas, yaitu Dinas Pagi, Sore dan Malam. Dokter Umum merangkap sebagai dokter IGD dan dokter jaga ruangan.
2. Tenaga Perawat
 - a. Terdiri dari Bidan dan Perawat di ruangan yang berjaga secara on site, dalam 24 jam terbagi menjadi 3 waktu dinas, yaitu Dinas Pagi, Sore dan Malam.



- b. Pembagian waktu jam dinas yaitu
 - 1) Dinas Pagi dari jam 06.30 - 14.00
 - 2) Dinas Sore dari jam 14.00 - 21.00
 - 3) Dinas Malam dari jam 21.00 - 07.00
- c. Pengaturan jadwal dinas Perawat di ruangan dilakukan oleh Kepala Ruangan
- d. Apabila ada pegawai yang mengalami sakit atau ada anggota keluarga yang meninggal, serta musibah maka penjadwalan dinas diatur kembali oleh Kepala ruangan, dan tidak ada penggantian dinas.



BAB III

STANDART FASILITAS

3.1 Denah Ruangan Terlampir

3.2 Standart Fasilitas

NO	NAMA RUANGAN	FUNGSI	BESAR RUANG/LUAS	KEBUTUHAN FASILITAS
1	Ruang Perawatan NICU	Ruangan untuk pasien yang memerlukan asuhan dan pelayanan keperawatan dan pengobatan secara berkesinambungan lebih dari 24 jam	Ukuran ruangan minimal 6m x 8m	Inkubator, bok bayi, CPAP, Suction, Ventilator, Resusitasi kit, Fototerapi
2	Ruang Stasi Perawat (Nurse Station)	Ruang untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian asuhan dan pelayanan keperawatan (pre dan postconference, pengatur jadwal), dokumentasi sampai dngan evaluasi pasien	3-4 m2/perawat (Ket:perhitungan stase perawat untuk melayani maksimum 6 tempat tidur)	Meja, Kursi, lemari arsip, lemari obat, telepon/intercom alat minitoring untuk pemantauan terus menerus fungsi-fungsi vital pasien
3	Ruang Linen Bersih	Tempat penyimpanan bahan-bahan linen steril/bersih	Min. 4 m2	Lemari
4	KM/WC (petugas)	KM/WC	KM/WC Pria/wanita luas 2 m ² - 3 m ²	Kloset, wastafel, bak air

3.1 Persyaratan Khusus

Perletakan ruangnya secara keseluruhan perlu adanya hubungan antar ruang dengan skala prioritas yang diharuskan dekat dan sangat berhubungan/membutuhkan.

- Kecepatan bergerak merupakan salah satu kunci keberhasilan perancangan, sehingga blok unit sebaiknya sirkulasinya dibuat secara linen/lurus (memanjang).
- Konsep Rawat Inap yang disarankan “Rawat Inap Terpadu (Integrated Care)” untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang.
- Bangunan Ruang Rawat Inap harus terletak pada tempat yang tenang (tidak bising), aman dan nyaman tetapi tetap memiliki kemudahan aksesibilitas dari sarana penunjang rawat inap.
- Alur petugas dan pengunjung dipisah.
- Lantai harus kuat dan rata tidak berongga, bahan penutup lantai, mudah



dibersihkan, bahan tidak mudah terbakar.

- f. Pertemuan dinding dengan lantai disarankan berbentuk lengkung agar memudahkan pembersih dan tidak menjadi tempat sarang debu/kotoran.
- g. Plafon harus rapat dan kuat, tidak rontok dan tidak menghasilkan debu/kotoran lain
- h. Khusus untuk pasien-pasien tertentu harus dipisahkan seperti:
 - a) Pasien yang menderita penyakit menular
 - b) Pasien dengan pengobatan yang menimbulkan bau (seperti penyakit tumor, ganggren, diabetes, dsb)
- i. Nurse Station perawat harus terletak di pusat blok yang dilayani agar perawat dapat mengawasi pasiennya secara efektif, maksimum melayani 6 tempat tidur
- j. Adanya CCTV yang aktif 24 jam guna untuk menjaga keselamatan bayi atau menghindari adanya menculikan bayi atau kejadian bayi tertukar.



BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

4.1 Kriteria Pasien Masuk NICU

Sebelum pasien masuk NICU, keluarga harus mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai dasar pertimbangan mengapa pasien harus mendapat perawatan di NICU, serta tindakan medis yang mungkin dilakukan selama pasien dirawat di NICU. Penjelasan tersebut diberikan oleh perawat NICU atau dokter spesialis anak yang menangani pasien. Atas penjelasan tersebut keluarga dapat menerima/ menyatakan persetujuan untuk dirawat NICU. Persetujuan dinyatakan dengan menandatangani formulir *informed consent*.

- Syndrom Gawat Nafas/ Respiratory Distress Syndrome
- Transient Tachyoneu of Newborn* (TTN)
- Hyalin Membrane Disease* (HMD)
- Pneumonia neonatal
- Asfiksia
- Aspirasi meconium,
- Ancaman gagal nafas dan gagal nafas
- Bronkopneumonia displasia* (BPD), memerlukan oksigenasi intensif dan agresif
- Anemia
- Apnea
- Perdarahan Saluran Cerna atas dan bawah yang masif
- Necrotizing Enterocolitis Necrotion* (NEC)
- Syok Hipovolemik
- Post Resusitasi
- Kejang
- Kern ikterik/ ensefalopaty hiperbilirubinemia
- Hemorrhagic Disease of newborn* (HDN)
- Bayi berat badan lahir amat/ sangat rendah (<1500 gram) atau bayi dengan kelahiran usia gestasi <34 minggu dengan batas usia 60 hari setelah kelahiran.
- Ikterik Neonatorum yang perlu terapi fototerapi dan terapi cairan dengan hasil bilirubin bayi > 20 mg/dl
- Neonatus yang memerlukan nutrisi parenteral total atau parsial.

4.2 Kriteria Pasien Keluar NICU

- Bayi telah menunjukkan tanda vital stabil di boks terbuka selama 24-48 jam. Normalnya, suhu tubuh bayi 36,5⁰ C-37,5⁰ C, frekuensi pernapasan 30-40 x/mt, nadi 120-160 x/mt.
- Keberhasilan menyusui sudah mulai tercapai
- Penambahan berat badan dengan pemberian asupan per oral telah terlihat
- Semua obat yang diperlukan dapat diberikan per oral
- Nilai laboratorium telah normal
- Ibu dan ayah memperlihatkan kemampuan untuk mengasuh neonatus
- Pasien meninggal
- Rujuk
- Pulang Paksa (APS)

4.3 Monitoring Dan Evaluasi Pasien

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan dengan



menggunakan lembar kardek guna mewujudkan pelayanan NICU yang aman dan mengutamakan keselamatan pasien.

Monitoring dan evaluasi dimaksud harus ditindaklanjuti untuk menentukan faktor-faktor yang potensial berpengaruh agar dapat diupayakan penyelesaian yang efektif.

4.4 Jenis Pelayanan di ruang NICU

- a. Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis.
- b. Perawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan secara berkala.
- c. Edukasi keluarga pasien oleh perawat dan TIM kesehatan lain.
- d. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan.
- e. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis.
- f. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
- g. Tindakan Medis yang bersifat diagnostik dan terapeutik.
- h. Pemberian obat-obatan pada pasien sesuai dengan catatan daftar obat pasien dan instruksi dokter spesialis.
- i. Pelayanan Tranfusi Darah.

4.5 Penggunaan Alat Medik

- a. Inkubator
- b. Baby scale
- c. Neonatal transport incubator
- d. Infusion pump
- e. Suction
- f. Standar infuse
- g. Bag mask neonatus
- h. Termometer digital
- i. Phototerapi
- j. Humidifier
- k. Pulse oximetri
- l. CPAP
- m. Stetoskop bayi
- n. Ventilator
- o. Syringe Pump

4.6 Hal-hal Yang Harus Diperhatikan

- a. Obserasi keadaan umum pasien tiap 1 jam
- b. Observasi tanda – tanda vital tiap 1 jam
- c. Pengukuran intake dan output pasien tiap 24 jam
- d. Merubah posisi 2 – 3 jam sekali.

4.7 Pasien Pulang

- a. Resume Pasien Pulang
 - a) Pasien pulang diperoleh setelah hasil evaluasi dokter tindakan terapi diberhentikan dan diperbolehkan pulang
 - b) Lakukan resume pasien sebagai bahan untuk kontrol dan keperluan riwayat penyakit dalam pertimbangan terapi yang akan datang
- b. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut lakukan edukasi asuhan perawatan di rumah yang berhubungan dengan asuhan:



- a) Perawatan tali pusat
- b) Perawatan menjemur bayi
- c) Edukasi laktasi
- d) Pemberian obat
- e) Memandikan bayi
- f) Asuhan yang bersifat khusus bagi pasien dengan kasus khusus
- c. Pasien Meninggal
 - a. Bila pasien meninggal lakukan asuhan jenazah di ruangan NICU
 - 1) Buka semua peralatan yang menempel di pasien
 - 2) Buka baju pasien
 - 3) Ikat tangan pasien tangan kanan memegang tangan kiri
 - 4) Tutup dengan laken
 - 5) Tunggu 2 jam
 - 6) Informasikan bagian ambulan dan jenazah
 - b. Pasien dirujuk
Pasien dirujuk bila atas indikasi tidak dapat dilakukan di rumah sakit dikarenakan sarana tidak lengkap, permintaan sendiri dari pasien adapun persiapan yang harus dilakukan
 - 1) Lakukan komunikasi dengan tempat yang akan menerima rujukan (lihat Panduan Transfer Pasien)
 - 2) Bila sudah tersedia ruangan maka hubungi ambulan
 - 3) Setelah siap ambulan kondisikan tim yang akan merujuk sesuai dengan kondisi pasien (lihat pada panduan transfer pasien)
 - 4) Transportasi pasien menggunakan inkubator

4.8 Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Pelayanan

1. Laporan Harian

Laporan harian dibuat untuk seluruh pasien NICU, laporan ini terdiri dari laporan 3 shift yaitu pagi, siang dan malam yang dilakukan saling berkesinambungan isi dari laporan tersebut adalah:

- a) Identitas pasien
- b) Observasi tanda – tanda vital
- c) Cairan yang didapat pasien, dan jumlah cairan yang keluar dan masuk.
- d) Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien setiap harinya
- e) Obat-obatan yang didapat pasien dan alat – alat yang terpasang pada pasien

2. Laporan bulanan

Laporan kepala ruang kepada kabid keperawatan



BAB V

LOGISTIK

Kebutuhan barang-barang logistik di Instalasi NICU terdiri dari barang tetap dan barang habis pakai. Barang tetap terdiri dari peralatan medis, peralatan keperawatan, alat tenun dan peralatan rumah tangga. Sedangkan barang habis pakai terdiri dari : Obat-obatan dan bahan habis pakai alkes (BHP), alat kebersihan, Cetakan dan Alat Tulis Kantor (ATK). Untuk proses pengadaan barang habis pakai di tiap ruangan melalui 3 proses, yaitu :

1. Perencanaan
Kepala Ruangan mendata kebutuhan barang (BHP, alat kebersihan, cetakan dan ATK) dalam 1 minggu
2. Permintaan
Permintaan kebutuhan barang perminggu ruangan dilakukan setiap hari rabu untuk ATK, dan permintaan BHP farmasi dilakukan pada hari sabtu
3. Penyimpanan
Penyimpanan barang dilakukan di tiap ruangan selama 1 minggu

5.1 Barang Tetap

1. Peralatan Keperawatan
 - a. Inkubator
 - b. Baby scale
 - c. Neonatal transport incubator
 - d. Infusion pump
 - e. Suction
 - f. Standar infuse
 - g. Bag mask neonatus
 - h. Termometer digital
 - i. Phototerapi
 - j. Humidifier
 - k. Pulse oximetri
 - l. CPAP
 - m. Stetoskop bayi
 - n. Ventilator
 - o. Syringe Pump
2. Alat Tenun
 - a. Selimut bayi
 - b. Sprey infant warmer
 - c. Sprei bayi
 - d. Sarung bantal bayi
3. Peralatan Rumah Tangga
 - a. Lemari
 - b. Kulkas
 - c. Tempat sampah
 - d. Jam dinding
 - e. Meja Perawat
 - f. Dispenser
 - g. Kursi Perawat
 - h. Troli Tindakan



- i. 1 Unit Komputer
- j. 1 Unit Telepone
- k. 3 Unit AC
- l. 1 Unit Kipas Angin

5.2 Barang Habis Pakai

1. Obat-obatan dan bahan habis pakai (BHP)
 - a. Tiap ruangan dalam Instalasi Perinatologi memiliki persediaan obat dan bahan habis pakai yang berasal dari bagian farmasi untuk keadaan kegawat daruratan sesuai dengan standar therapy
 - b. Pemakaian obat pasien dilakukan dengan cara meresepkan obat sesuai kebutuhan dan disimpan dalam loker obat pasien selama pasien dirawat di ruangan rawat inap.
2. Alat kebersihan
Regulasi sesuai dengan kebutuhan di ruangan
3. Alat tulis kantor
Regulasi sesuai dengan kebutuhan ruangan



BAB VI

KESELAMATAN PASIEN

6.1 Pengertian

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi : assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Mengingat keselamatan pasien sudah menjadi tuntutan masyarakat maka upaya pelaksanaan keselamatan pasien di RS perlu dilakukan. Untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan RS terutama di dalam melaksanakan keselamatan pasien sangat diperlukan suatu pedoman yang jelas sehingga angka kejadian KTD dapat dicegah sedini mungkin.

6.2 Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit.
2. Meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat.
3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit.
4. Terlaksananya program – program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan.

6.3 Tata Laksana Keselamatan Pasien

1. Keselamatan pasien merupakan hal yang terutama dalam pelayanan keperawatan.
2. Terdapat perawat yang memahami mengenai keselamatan pasien.
3. Terdapat sistem pelayanan yang komprehensif, baik medis maupun keperawatan sehingga meminimalkan terjadinya kasus yang tidak diharapkan (KTD).
4. Identifikasi pasien harus dilakukan secara lengkap, baik berupa status maupun gelang identitas.
5. Sarana dan prasarana harus mengindahkan keselamatan pasien : sterilitas alat, tabung oksigen, tempat tidur dorong, privacy, dll.
6. Sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien petugas melakukan kebersihan tangan procedural perina.
7. Terdapat evaluasi berkala kelengkapan sarana dan prasarana.
8. Terdapat pelaporan kasus yang tidak diharapkan, yaitu :
 - a. Insidens kesalahan identifikasi kedaruratan pasien.
 - b. Insidens pasien jatuh.
 - c. Insidens kejadian infus blong.
 - d. Insidens kesalahan pemberian obat.
 - e. Insidens kesalahan cara pemberian obat.
 - f. Insidens kesalahan persiapan pemeriksaan penunjang
9. Membangun kesadaran atau budaya akan nilai keselamatan pasien



BAB VII

KESELAMATAN KERJA

7.1 Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi. Keselamatan kerja merupakan tugas semua orang yang berada di rumah sakit termasuk instalasi farmasi dengan demikian keselamatan kerja adalah dari, oleh dan untuk setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di rumah sakit serta masyarakat di sekitar rumah sakit yang mungkin terkena dampak akibat suatu proses kerja. Dengan demikian jelas bahwa keselamatan kerja adalah merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian yang berupa luka/cidera, cacat/ kematian, kerugian harta benda dan kerusakan peralatan mesin dan lingkungan secara luas.

Dalam menerapkan kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, NICU disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit, dengan selalu berkoordinasi dengan Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja RS Prima Husada Sukorejo dan unit terkait lainnya.

7.2 Prinsip Dasar Usaha Kesehatan Kerja

Prinsip dasar usaha kesehatan kerja terdiri atas : Ruang lingkup usaha kesehatan kerja. Kesehatan kerja meliputi berbagai upaya penyesuaian antara pekerja dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya baik fisik maupun psikis dalam hal cara / metode kerja dan kondisi yang bertujuan untuk :

- 1) Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan kerja masyarakat pekerja di semua lapangan kerja setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun kesejahteraan sosial.
- 2) Mencegah timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh keadaan / kondisi lingkungan kerjanya.
- 3) Memberikan pekerjaan dan perlindungan bagi pekerja didalam pekerjaannya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan.
- 4) Menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjaan.

7.3 Tujuan Keselamatan Kerja

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan ketika melakukan pekerjaan
2. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya paparan dari zat kimia yang membahayakan
3. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis
4. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
5. Menerapkan ergonomi di tempat kerja
6. Mengamankan dan memelihara alat-alat perlengkapan farmasi
7. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
8. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
9. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi



7.4 Kapasitas Kerja dan Beban Kerja

Kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja merupakan tiga komponen utama dalam kesehatan kerja, dimana hubungan interaktif dan serasi antara ketiga komponen tersebut akan menghasilkan kesehatan kerja yang optimal. Kapasitas kerja seperti status kesehatan kerja dan gizi kerja serta kemampuan fisik prima diperlukan agar seorang pekerja dapat melakukan pekerjaannya secara optimal. Kondisi atau tingkat kesehatan pekerja yang prima merupakan modal awal seseorang untuk mencapai produktifitas yang diharapkan. Kondisi awal seseorang untuk bekerja dapat dipengaruhi oleh kondisi temperatur kerja, gizi kerja, kebugaran jasmani dan kesehatan mental. Beban kerja meliputi fisik maupun mental. Akibat beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang pekerja menderita gangguan atau penyakit akibat kerja.

7.5 Lingkungan Kerja dan Penyakit Kerja yang Ditimbulkannya

Penyakit akibat kerja dan / atau berhubungan dengan pekerjaan dapat disebabkan oleh pemajanan di lingkungan kerja. Fakta di lapangan menunjukkan terdapat kesenjangan antara pengetahuan tentang bagaimana bahaya kesehatan berperan dan usaha untuk mencegahnya antara kognisi dan emosi. Misalnya alat pelindung kerja yang tidak digunakan secara tepat oleh pekerja rumah sakit dengan kemungkinan terpajan melalui kontak langsung atau tidak tersedianya pelindung. Untuk mengantisipasi permasalahan ini maka langkah awal penting adalah pengenalan / identifikasi bahaya yang dapat ditimbulkan upaya perlindungan dan penanggulangan dan dievaluasi kemudian dilakukan pengendalian.

7.6 Klasifikasi Kecelakaan Kerja

Klasifikasi kecelakaan kerja di Instalasi NICU secara garis besar, diantaranya :

1. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan
 - a. Terjatuh
 - b. Tersandung benda
 - c. Terbentur alat
 - d. Terkena arus listrik dll
2. Klasifikasi menurut agen penyebabnya
 - a. Alat-alat keperawatan seperti tertusuk jarum suntik, terbentur, dll
 - b. Lingkungan kerja, seperti ruangan panas, pencahayaan kurang.
3. Klasifikasi menurut jenis luka dan cideranya
 - a. Efek terkena zat kimia
 - b. Efek terkena menghirup obat
 - c. Patah tulang
 - d. Keseleo/dislokasi/terkilir
 - e. Kenyerian otot dan kejang
 - f. Luka tergores
4. Klasifikasi menurut lokasi bagian tubuh yang terluka
 - a. Kepala, leher, badan, lengan, kaki dan berbagai bagian tubuh lainnya
 - b. Luka umum dsb
5. Pencegahan kecelakaan kerja
Pencegahan kecelakaan kerja yang dilakukan instalasi NICU diantaranya adalah :
 - a. Desain ruangan
Ruangan NICU di desain dengan aturan yang berlaku.
 - b. Meja ners station



Selalu bersih dan dan tidak ada makanan.

- c. Berhati-hati melakukan tindakan
- d. Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) dan memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai indikasi
- e. Sosialisasi SPO Praktek Menyuntik Aman dan SPO penggunaan APD



BAB VIII

PENGENDALIAN MUTU

8.1 Upaya Peningkatan Mutu Keperawatan

Upaya untuk menjamin mutu pelayanan asuhan keperawatan di RS bidang keperawatan membuat Program Pengendalian dan Peningkatan Mutu sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan peningkatan mutu.

Perumusan dan penyusunan kebijakan pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi melalui masukan dari seluruh jajaran dan staf keperawatan yang terlibat dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja bidang keperawatan secara periodik yang kemudian ditindaklanjuti untuk dilaporkan kepada Direksi.

Kegiatan dalam upaya pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan, dapat dilakukan melalui :

1. Audit Keperawatan

Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada klien. Hal ini cukup penting karena kekurangan dalam pelayanan keperawatan dapat mengancam jiwa dan kehilangan nyawa klien.

Langkah-langkah dalam melaksanakan audit keperawatan

- a. Menentukan masalah tertentu untuk dipelajari dan diulas.
- b. Menentukan kriteria atau standar profesi yang jelas, obyektif dan rinci
- c. Mempelajari catatan keperawatan dan catatan medik
- d. Para perawat mempelajari kasus yang tidak memenuhi kriteria, dianalisis, didiskusikan kemungkinan penyebabnya.
- e. Membuat rekomendasi penanganan kasus yang tidak memenuhi kriteria.
- f. Membuka lagi topik yang sama di lain waktu, misalnya setelah 6 bulan kemudian, untuk menilai dan meyakinkan bahwa kelemahan/ kekurangan yang diidentifikasi telah diperbaiki dan tidak diulang kembali.
- g. Perlu dipastikan bahwa audit keperawatan ini bukan acara pengadilan dari kekurangan pelayanan yang ada tetapi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.
- h. Audit keperawatan paling tidak dilakukan sebulan sekali membahas tentang pelaksanaan asuhan keperawatan/kebidanan di RSU.

2. Survey Kepuasan Pasien.

Suatu kegiatan untuk mendapatkan masukan dari pasien atau keluarga mengenai kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan melalui pengisian angket oleh pasien atau keluarga pasien.

8.2 Monitoring dan Evaluasi Mutu Keperawatan

Monitoring terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan dilakukan oleh seluruh pengelola keperawatan termasuk kepala perawat di unit pelayanan masing-masing. Upaya perbaikan yang berkaitan dengan mutu keperawatan akan dilakukan secara terus menerus di unit pelayanan. Sedangkan evaluasi akan dilakukan setahun sekali oleh Kabid Keperawatan.



BAB IX

PENUTUP

Pelayanan Neonatus Intensive Care Unit yang dilaksanakan di rumah sakit hendaknya senantiasa sejalan dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan kedokteran. Selain itu, dalam rangka menyongsong era globalisasi dan menghadapi persaingan bebas, maka pelayanan perinatologi rumah sakit juga harus dipersiapkan secara profesional. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit selanjutnya akan meningkatkan nilai jualnya.

Pelayanan Neonatus Intensive Care Unit merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit, dan merupakan salah satu pelayanan yang dapat diunggulkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan.

Buku pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dan sistematis dalam mengelola dan melaksanakan pelayanan perinatologi di rumah sakit yang tepat bagi pasien. Selain itu, pedoman ini bermanfaat bagi pengelola rumah sakit dalam mengimplimentasikan dan mengevaluasi kemajuan dan perkembangan pelayanan Neonatus Intensive Care Unit.

Ditetapkan di Pasuruan pada

tanggal 25 November 2025

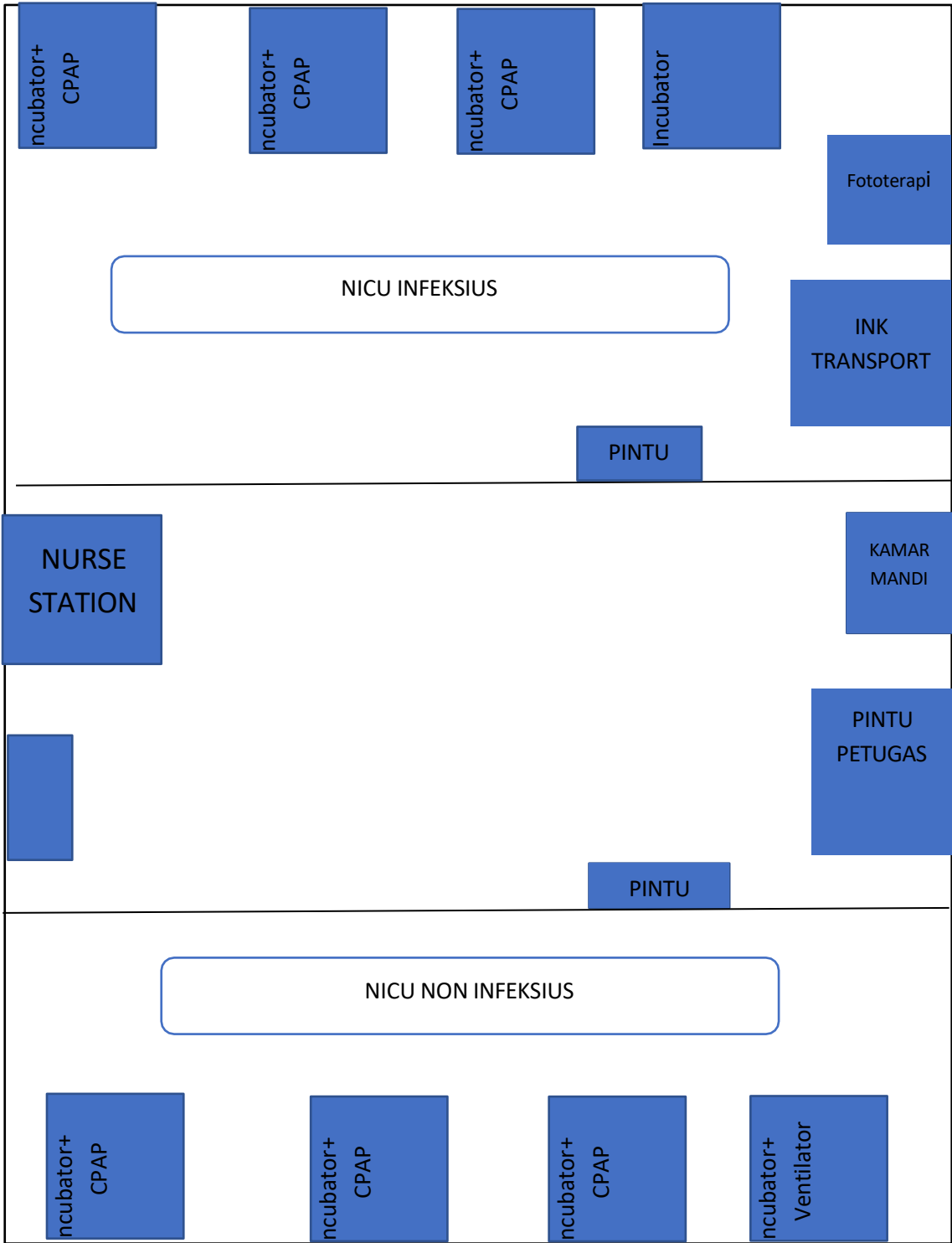
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulandari, S. Kep., M.Kep

LAMPIRAN II :
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 935.109/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG : PEDOMAN PELAYANAN NICU
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Lampiran Denah Ruangan





LAMPIRAN III:

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA**

NOMOR : 935.109/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

**TENTANG : PEDOMAN PELAYANAN NICU
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

Alur pasien dari dan ke NICU (Neonatal Intensive Care Unit)

